

Université de Constantine 3- Faculté de médecine
Centre Hospitalo-universitaire de Constantine Dr Benbadis
Service de Médecine Interne

Valvulopathies mitrales

Cours de sémiologie

Etudiants de 3ème année médecine

Dr Kermiche Meriem

Année 2023/ 2024

Plan du cours :

1. *Introduction*
2. *Physiopathologie*
3. *Rétrécissement mitral*
 - a. *Définition*
 - b. *Signes cliniques*
 - c. *Signes radiologiques*
 - d. *Signes électriques*
4. *Insuffisance mitrale*
 - a. *Définition*
 - b. *Signes cliniques*
 - c. *Signes radiologiques*
 - d. *Signes électriques*

Références

1. Introduction :

Le cœur comprend quatre valves :

À droite, on distingue deux valves : la valve tricuspide et la valve pulmonaire

Le cœur gauche comprend : La valve aortique et la valve mitrale

La valve mitrale, atrioventriculaire, est formée de deux valvules ; elle permet la séparation de l'atrium gauche du ventricule gauche

Les valvulopathies réalisent des maladies des valves cardiaques qui peuvent être soit à type de rétrécissement, soit à type d'insuffisance

2. Physiopathologie :

Le rétrécissement mitral réalise un barrage diastolique au passage du sang de l'OG vers le VG et en conséquence :

- **En aval :** ↓ du débit cardiaque ; VG non dilaté et de fonction conservée
- **En amont :** Dilatation de l'OG : prédispose aux troubles du rythme auriculaire ; thromboses de l'OG avec risque d'embolies systémiques → augmentation de la pression capillaire pulmonaire → augmentation des résistances pulmonaires → hypertension artérielle pulmonaire → insuffisance Cardiaque droite (phase terminale tardive)

Insuffisance mitrale chronique :

- **Conséquence en amont :** régurgitation vers OG en systole → dilatation de l'OG (HTAP, Troubles du rythme, embolies). Mêmes conséquences en amont que le RM.
- **En aval :** Surcharge puis dilatation du VG (due à la fuite et compensation pour augmentation du volume éjecté) → dilatation de l'anneau mitral → aggrave la fuite

Insuffisance mitrale aigue : surcharge volumétrique aigu de l'OG (non modifiée) → hyperpression transmise en amont → risque hémodynamique avec insuffisance cardiaque aiguë

3. Le rétrécissement mitral :

a. Définition :

Diminution de l'ouverture de l'orifice mitral par anomalie des valves mitrales faisant obstacle au flux sanguin de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche ; à chaque diastole.

b. Signes cliniques :

De nombreuses patientes restent longtemps asymptomatiques

L'obstacle au flux sanguin aboutit à une augmentation des pressions au niveau de l'oreillette gauche et des capillaires pulmonaires ; ce qui explique que les symptômes fonctionnels qui seront au premier plan sont d'ordre pulmonaire.

Signes fonctionnels :

- La dyspnée d'effort : évoluant vers une dyspnée de repos et l'orthopnée (crises d'œdème aigu du poumon) Elle est majorée par toute situation augmentant le débit cardiaque : grossesse, anémie, infection (pneumopathie), fièvre, hyperthyroïdie ...
- Les hémoptysies.
- Autres signes : **palpitations** (troubles du rythme atriale), un **enrouement** (dysphonie) dû à la compression du nerf laryngé récurrent gauche par une oreillette gauche ou par une artère pulmonaire (**syndrome d'Ortner**)
- des embolies systémiques avec des symptômes d'accidents vasculaires cérébraux ou d'ischémie d'autres organes

Signes physiques :

- Inspection : Le classique faciès mitral, coloration rouge cyanotique des pommettes est tardif (dû à une vasodilatation cutanée et une hypoxémie chronique)

Le malade étant placé en décubitus dorsal et surtout en décubitus latéral gauche. Au niveau de la pointe du cœur (foyer mitral)

- Palpation : Frémissement cataire diastolique à l'apex témoin d'un roulement intense

Un choc du ventricule droit (soulèvement) palpable dans la région parasternale gauche (signe de Harzer)

- Auscultation : temps capital
 - Le claquement d'ouverture de la mitrale (COM) : bruit protodiastolique, claqué, sec, survenant après B2.
 - Le roulement diastolique : qui débute après le claquement d'ouverture de la mitrale et qui comporte deux renforcements : le premier proto-diastolique (correspondant à la période de remplissage rapide du ventricule), il est d'emblée maximal et va decrescendo ; un deuxième renforcement présystolique (qui correspond à la contraction auriculaire) et qui disparaît en cas de fibrillation auriculaire. Ce roulement est mieux entendu après l'effort et en expiration forcée.
 - L'éclat de B1 : à tonalité élevée ; fermeture brutale de la valve mitrale sténosée ; B1 peut être absent si valvule fortement calcifiée et immobile

La triade : COM, roulement diastolique, éclat de B1, réalise le rythme de Duroziez



- Rechercher une ou des valvulopathies associées : RM + IM = maladie mitrale

Si HTAP : Éclat de B2 au foyer pulmonaire

- Les signes radiologiques :** se résument à des signes d'hypertrophie dilatation de l'oreillette gauche visible sur la radiographie de face et en OAD.

— Radiographie de face : saillie convexe de l'arc moyen gauche à sa partie inférieure et aspect de double contour de l'arc inférieur droit.

— OAD : saillie convexe refoulant l'œsophage en arrière

Le tronc de l'artère pulmonaire peut être proéminent ; lignes horizontales dans les champs pulmonaires (stries de Kerley) indiquent un œdème interstitiel

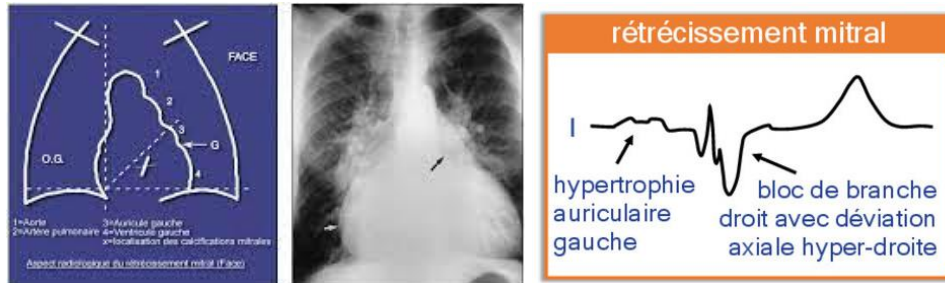


Figure : aspects radiologiques (1) et électro-cardiographiques (2) avec rétrécissement mitral

- a. **Les signes électriques :** dilatation et ou hypertrophie auriculaire gauche : onde P d'une durée $> 0,12$ s ; onde P bifide

Hypertrophie du ventricule droit : amplitude importante des ondes R en V1 ; déviation axiale droite du QRS

4. Insuffisance mitrale :

a. Définition :

- L'insuffisance mitrale est due à l'absence d'étanchéité des valvules, entraînant une régurgitation du sang du ventricule gauche dans l'oreillette gauche pendant la systole ventriculaire
- Elle peut être primaire : causes fréquentes sont le prolapsus de la valvule mitrale et la fièvre rhumatismale
- Ou secondaire : à une dilatation du ventricule gauche ou à un infarctus

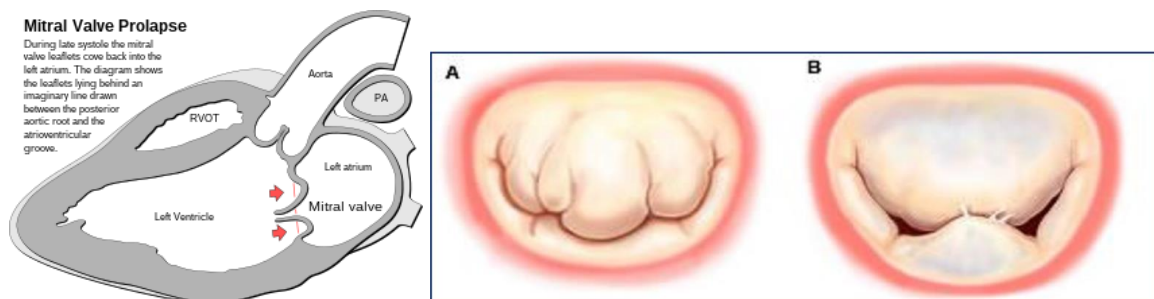


Figure : Prolapsus de la valve mitrale

a. Signes cliniques :

Signes fonctionnels :

- Les signes sont discrets ; la dyspnée d'effort est en règle d'apparition tardive
- Dyspnée de décubitus.
- Palpitations (FA) ... (mêmes signes que le RM)

- L'asthénie (due à une insuffisance cardiaque)
- Rarement, les patients ont à la présentation une endocardite (p. ex., avec fièvre, perte de poids, embolies)

Signes physiques :

- Ils sont retrouvés à la pointe sur le sujet en décubitus dorsal.
- A la palpation : un frémissement systolique est rarement retrouvé ; il correspond à un souffle systolique intense ; une déviation en bas et en dehors du choc de pointe (si VG dilaté et hypertrophié)
- Auscultation cardiaque + + + : (décubitus latéral gauche)
- un souffle systolique de régurgitation qui présente les caractères suivants :
 - Temps : holosystolique.
 - Siège : pointe.
 - Irradiations : aisselle gauche et dos.
 - Timbre : rude et sec, en jet de vapeur.
 - Intensité variable.
- Il est mieux entendu après effort et en expiration forcée



- À l'auscultation, le 1er bruit cardiaque (B1) peut être doux (ou parfois fort). Un 3e bruit de cœur (B3) à la pointe reflète une dilatation du ventricule gauche et une insuffisance mitrale sévère dyspnée de décubitus.
- Les souffles d'insuffisance mitrale peuvent être confondus avec une régurgitation tricuspidiennne, qui se reconnaît par le fait que le souffle de régurgitation tricuspidiennne augmente à l'inspiration
- L'insuffisance mitrale aiguë provoque la même symptomatologie que l'insuffisance cardiaque aiguë (dyspnée, fatigue, faiblesse, œdème) et que le choc cardiogénique (hypotension qui induit des lésions multisystémiques)

b. Signes radiologiques:

- Ils associent des signes d'hypertrophie, dilatation de l'oreillette gauche et du ventricule gauche.
- **Radiographie de face :** l'hypertrophie de l'oreillette gauche se manifeste par une saillie de l'arc moyen gauche, celle du, ventricule gauche par une saillie de l'arc inférieur gauche.

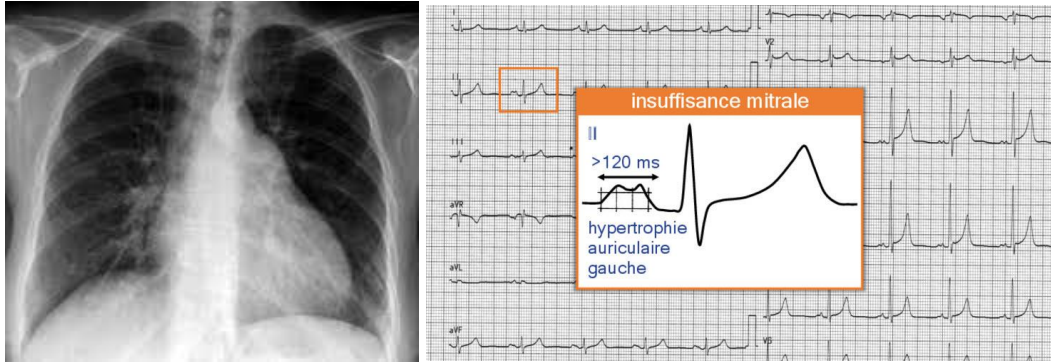


Figure : aspects radiologiques (1) et électro-cardiographiques (2) avec insuffisance mitrale

c. Signes électriques :

- Une dilatation de l'oreillette gauche
- Signes d'insuffisance ventriculaire gauche de type diastolique (ondes Q-R et T de forte amplitude en V5-V6)

Références :

- 1) Rose-Marie Hamladji, Précis de Sémiologie, en ligne depuis : <https://www.sofiotheque.info/2016/09/precis-de-semiologie-rose-marie.html>
- 2) Guy P .Armstrong et al, Rétrécissement mitral, juil. 2022, en ligne depuis : <https://www.msmanuals.com/fr/professional/troubles-cardiovasculaires/valvulopathies/r%C3%A9tr%C3%A9cissement-mitral#:~:text=Le%20r%C3%A9tr%C3%A9cissement%20mitral%20est%20une,est%20le%20rhumatisme%20articulaire%20aigu.>
- 3) Guy P .Armstrong et al, Insuffisance mitrale, juil. 2022, en ligne depuis : <https://www.msmanuals.com/fr/professional/troubles-cardiovasculaires/valvulopathies/insuffisance-mitrale>